

자궁경부암 진단 첫 30일

병기 · 수술 · 항암방사선치료 핵심 정리

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 12

MINI 무료 배포판 · Instagram 구독자용 · 2026년 10월 개정 2판

“HPV 양성”과 “침윤성 자궁경부암 확진”은 같은 말이 아닙니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Cervical Cancer, Version 2.2026 외 국내 자료 (본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 MINI판에 대하여

이 MINI판은 진단 후 첫 30일 동안 **안전하게 판단하는 데 꼭 필요한 내용만** 담았습니다. 응급 신호, 진단 직후 할 일, 병리·병기의 핵심, 치료 흐름, 진료실 질문, 한 장 요약은 완전판과 같습니다. 30일 일자별 실행 로드맵, 치료별 준비·회복 가이드, 한국 제도·보험 서류 안내, 마음 돌보기와 보호자 가이드, 워크북은 완전판에 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: 전암병변과 침윤암

30초 요약

- **HPV 양성 ≠ 암.** 비정상 세포검사나 HPV 양성은 "더 확인이 필요하다"는 뜻입니다.
- **전암병변(CIN·AIS) ≠ 침윤암.** 치료 범위가 완전히 다릅니다.
- 침윤암은 **조직검사로 확진**하고, 종양 크기·주변 침범·림프절·원격전이를 보고 **FIGO 병기**를 정합니다.
- 임신을 원한다면 **치료를 정하기 전에** 말해야 합니다.

결과지에 적힌 말	뜻	이 책에서 볼 곳
HPV 양성, ASC-US, LSIL	세포 변화나 바이러스 감염. 암 확진이 아님	6장
CIN2·CIN3, HSIL, AIS(상피내선암)	전암병변. 원추절제 등으로 치료	1장 아래 상자
미세침윤암(IA)	현미경으로만 보이는 아주 초기 침윤암	5·8·9장
침윤성 편평상피암·선암· 선편평상피암	자궁경부암 확진	이 책 전체
신경내분비암(소세포암 등)	드물고 치료 경로가 다름	14장

전암병변(CIN3·AIS)이라고 들었다면: 이 책의 많은 내용(병기·항암방사선)은 해당하지 않습니다. 원추절제 결과와 추적검사 일정을 담당 의사와 확인하세요. 다만 원추절제 후 "미세침윤"이 발견되면 이 책 5장부터 다시 보시면 됩니다. **근종 등으로 자궁을 뚫 뒀 침윤암이 나왔다면:** 남은 자궁주위조직·질 상부·골반 림프절을 더 떼는 수술이나 항암방사선을 검토합니다. 첫 수술 병원의 병리 슬라이드·수술기록지를 챙겨 부인종양 전문의에게 가세요.

자궁경부암의 조직형

- **편평상피암:** 가장 흔합니다. 자궁경부 바깥쪽(질 쪽)에서 주로 시작합니다.
- **선암:** 두 번째로 흔하며 자궁경부 안쪽(자궁 쪽)에서 시작합니다. 세포검사로 찾기 더 어려울 수 있습니다.
- **선편평상피암:** 두 가지가 섞인 형태.
- **신경내분비암(특히 소세포암):** 드물고 빨리 자랄 수 있어 별도 치료 경로를 따릅니다(14장).

첫 30일의 지도

순서	할 일	대략 시기
①	조직 확진 · 조직형 확인	Day 0-3
②	골반 MRI(국소) + PET/CT(원격) 등 병기 검사	Day 3-14
③	가임력 희망 여부를 의료진에게 알리기	첫 진료
④	수술 경로 vs 항암방사선 경로 결정	Day 10-21
⑤	치료 준비(난자 동결·난소전위·근접치료 병원 확보 등)	Day 14-30
⑥	진행·재발이면 PD-L1 등 바이오마커와 전신치료 계획	경우에 따라

오늘 물어볼 질문

1. 제 결과는 전암병변인가요, 침윤성 자궁경부암인가요?
2. 조직형은 무엇이고, 지금 예상하는 병기는 어디쯤인가요?
3. 최종 치료를 정하기 전에 어떤 검사가 더 필요한가요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ **응급 상자 — 아래 증상은 다음 예약까지 기다리지 말고 바로 연락하거나 응급실로**

- 패드가 1시간 안에 흠뻑 젖을 정도의 **질 출혈**, 어지럼·실신·가슴 두근거림
- **38°C 이상 발열**(특히 항암치료 중), 오한, 악취 나는 분비물과 심한 골반통
- **한쪽 다리가 갑자기 붓고 아픔**, 갑작스러운 흉통·숨참(혈전·폐색전 가능성)
- **소변이 거의 나오지 않음**, 심한 옆구리 통증(요관 막힘 가능성)
- 하루 6회 이상 설사나 반복 구토로 **물을 마실 수 없음**
- 새로 생긴 다리 힘 빠짐·감각 저하, 대소변 조절 이상, 심한 허리 통증
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ 109, 119

같은 내용을 본문 목록으로 한 번 더 적습니다. 보호자도 읽어 두세요.

1. 많은 질 출혈 + 어지럼 → 빈혈·급성 출혈 평가가 필요합니다.
2. 발열 + 오한 + 악취 분비물 + 골반통 → 감염 가능성이 있습니다.
3. 한쪽 다리 부종·통증, 흉통·호흡곤란 → 정맥혈전·폐색전 가능성이 있습니다.
4. 소변량 급감, 옆구리 통증 → 종양이 요관을 눌러 신장 기능이 떨어질 수 있습니다.
5. 치료 중 38°C 이상 발열, 탈수 → 혈구 감소나 감염 가능성이 있습니다.
6. 새 신경 증상 → 척추·신경 압박 가능성이 있습니다.

첫 치료 전에 할 일: 평일 진료실, 야간·휴일 연락처, 가까운 응급실을 내 휴대폰과 보호자 휴대폰에 저장하세요. 치료 중 응급 기준은 치료 병원 안내가 우선입니다.

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 세 가지만 하세요. ① 병리보고서 받기 ② 부인종양 전문의 진료 예약 ③ 임신 희망 여부 정리. 나머지는 이번 주에 해도 됩니다.

오늘 할 일 (3개)

- ☐ 병리보고서(조직검사 결과지) 사본 받기 — "침윤성 암"인지, 조직형이 무엇인지 확인
- ☐ **부인종양 전문의** 진료 예약 — 산부인과 중에서도 부인암 수술·치료를 전문으로 하는 의사
- ☐ 앞으로 임신을 원하는지 생각해 두기 — "모르겠다"도 괜찮습니다. 그 자체를 첫 진료에서 말하세요.

이번 주 할 일

- ☐ 어떤 방법으로 진단됐는지 확인(핀치 생검 / 원추절제(LEEP·냉원추절제))
- ☐ 병기 검사 일정 확인: 골반 MRI, PET/CT(또는 흉부·복부·골반 CT), 혈액검사
- ☐ 의료진이 권하면 **HIV 검사** — 국제 지침이 진단 시 권장하는 기본 검사입니다. HIV가 있어도 치료 선택지는 같으며, 양성이면 HIV 전문의와 함께 진료합니다.
- ☐ 다른 병원으로 옮기거나 2차 소견을 원하면 병리 슬라이드·블록, 영상 CD 대여 방법 확인
- ☐ **산정특례 신청** 여부를 원무과에 확인(확진일로부터 30일 이내 신청 시 확진일부터 적용, 공단 확인 필요)
- ☐ 흡연 중이라면 금연 지원 요청 — 치료 효과와 회복에 영향을 줍니다
- ☐ 현재 출혈량, 골반통, 소변·대변 변화, 체중·식사량 메모

보호자 몫

- ☐ 진료에 동행해 답을 받아 적기
- ☐ 연락처·일정 정리
- ☐ 환자에게 원인을 묻지 않기 — 특히 HPV에 대해서는 6장을 먼저 함께 읽어주세요

마음 점검 한 줄

지금 마음의 고통이 0~10 중 몇 점인지 적어 보세요: ____점. **4점 이상**이면 첫 진료에서 그대로 말하면 됩니다. 국제 지침은 진단 시점부터 마음 상태를 확인하도록 권합니다.

오늘 물어볼 질문

1. 제 진단은 침윤성 자궁경부암이 맞나요? 조직형은 무엇인가요?
2. 병기를 정하려면 어떤 검사를 언제 받나요?
3. 임신을 원한다면 치료 전에 무엇을 상의해야 하나요?

4장. 병리보고서 읽기

30초 요약: 병리보고서에서 먼저 볼 것은 **침윤암 여부 · 조직형 · 종양 크기 · 침윤 깊이 · LVSI · 절제면** 다섯 가지입니다.

항목	보고서 표현 예	왜 중요할까
침윤 여부	invasive / microinvasive / CIN3, AIS	전암과 암을 가르는 첫 기준
조직형	squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, adenosquamous, neuroendocrine	치료 경로, 가임력 보존·난소전위 가능성

항목	보고서 표현 예	왜 중요할까
침윤 깊이	depth of invasion 2.5 mm	IA1(3mm 미만) / IA2(3mm 이상 5mm 미만) 구분 — FIGO 2018은 가로 범위를 병기에 쓰지 않음
LVSI(림프혈관 침범)	LVSI present / absent	림프절 전이 위험 → 림프절 평가, 수술 범위, 가임력 보존
절제면	margin positive / negative	원추절제 후 추가 절제·수술 필요성

 **완전판에서 이어집니다** — 가상 병리보고서 한 줄씩 해설, 수술 후 최종 병리 항목 해설

병리보고서 기록

조직 형	침윤암	종양 크기· 깊이	LVSI	절제 면	신경내분비 특성
	☐ 예 ☐ 아니오		☐ 없음 ☐ 있음		☐ 없음 ☐ 있음 ☐ ?

5장. 검사와 FIGO 병기

30초 요약

- 국소 평가는 **골반 MRI**, 몸 전체(림프절·원격전이) 평가는 **PET/CT**가 우선 권고입니다. PET/CT가 어려우면 흉부·복부·골반 CT, MRI가 어려우면 질식 초음파를 씁니다.
- 병기 숫자보다 **"어디까지 퍼졌는지"**를 이해하는 것이 중요합니다.
- 영상에서 림프절이 커 보이는 것과 실제 전이는 같은 말이 아닙니다.

검사	무엇을 보나	메모
골반 MRI	종양 크기, 질·자궁주위조직·방광·직장 침범	방사선 없음, 조영제 사용
PET/CT	골반·대동맥주위 림프절, 폐·간·뼈 전이	목~허벅지 촬영. 급여 기준 확인
흉부·복부·골반 CT	PET/CT를 못 할 때 원격 평가	
혈액검사	혈구, 신장·간 기능	요관 막힘이 있으면 신장 수치 상승
방광경·직장경	방광·직장 침범 의심 시	필요할 때만

FIGO 2018 병기 한눈에 보기

병기	쉬운 뜻	치료 흐름의 예(개인마다 다름)
IA1	침윤 깊이 3mm 미만	원추절제 또는 단순 자궁절제, 가임력 보존 가능
IA2	3mm 이상 5mm 미만	원추절제/자궁절제 + 골반 림프절 평가
IB1	침윤 5mm 이상, 2cm 미만	수술(위험도에 따라 단순~근치), 선별적 가임력 보존
IB2	2~4cm 미만, 자궁경부에 국한	근치 자궁절제 또는 항암방사선
IB3	4cm 이상, 자궁경부에 국한	수술 또는 항암방사선 + 근접치료
IIA1 / IIA2	질 상부 2/3 침범(4cm 미만 / 4cm 이상)	IIA1 수술 가능, IIA2 수술 또는 항암방사선
IIB	자궁주위조직 침범	항암방사선 + 근접치료

병기	쉬운 뜻	치료 흐름의 예(개인마다 다름)
IIIA / IIIB	질 하부 1/3 / 골반벽 또는 수신증	항암방사선 + 근접치료
IIIC1 / IIIC2	골반 / 대동맥주위 림프절 전이	항암방사선 + 근접치료(대동맥주위면 조사 범위 확장)
IVA	방광·직장 점막 침범	근치 목적 항암방사선 고려
IVB	원격전이(폐·간·뼈·면 림프절 등)	전신치료 중심 ± 국소치료(13장)

같은 "1기"라도 종양 크기, LVSI, 림프절 위험, 가임력 희망에 따라 치료가 달라집니다. 병기 숫자만으로 수술 여부를 결정하지 않습니다. 수술 뒤에 병기가 바뀌는 일(예: IB1 → IIIC1)은 "오진"이 아니라 **수술로 더 많은 정보가 생긴 결과**인 경우가 많습니다.

■ 완전판에서 이어집니다 — 영상 판독지 용어 풀이, 수술적 림프절 병기 설명

검사 체크: 골반 MRI ☐ · PET/CT ☐ · CT ☐ · 혈액(신장 기능) ☐ · 방광경/직장경 ☐ · 림프절 평가 방법 __

오늘 물어볼 질문

1. 제 FIGO 병기는 무엇이고, 영상과 병리 중 무엇을 근거로 정했나요?
2. 림프절 전이는 확실한가요, 의심 단계인가요?
3. 이 병기에서 수술과 항암방사선 중 어느 쪽을 권하시나요?

6장. HPV 바로 알기 — 원인이지만 탓할 일은 아닙니다

30초 요약

- 고위험 HPV의 지속감염은 자궁경부암의 주요 원인입니다. 그러나 **HPV는 성생활을 하는 사람 대부분이 일생에 한 번쯤 노출되는 흔한 바이러스**입니다.
 - 암 진단은 **당신의 잘못이나 행실의 결과가 아닙니다**.
 - HPV 검사로 "누가 언제 옮겼는지" 알 수 없습니다. 바이러스는 수년간 잠복할 수 있습니다.
-
- 대부분은 면역이 스스로 HPV를 없애지만, 일부에서 오랜 기간 남아 세포를 바꿉니다. 이 과정은 보통 수년에서 수십 년이 걸립니다.
 - 진단 후에는 HPV 유형보다 **병리와 병기**가 치료 결정에 직접 쓰입니다.
 - 백신은 이미 생긴 암을 치료하지 않지만, 가족(자녀)의 예방에는 의미가 있습니다. 백신을 맞았어도 모든 고위험 유형을 막는 것은 아니어서 검진은 계속 필요합니다.
 - 치료 후 추적에서 세포검사·HPV 검사를 어떻게 쓸지는 치료 종류(수술/방사선)에 따라 다릅니다.

자주 듣는 오해와 사실: "HPV 양성이니 반드시 암이다" · "HPV 음성이면 자궁경부암이 아니다" · "백신을 맞았으니 검진이 필요 없다" · "파트너가 바람을 피웠다는 증거다" — 모두 사실이 아닙니다.

 **완전판에서 이어집니다** — 파트너·가족에게 HPV를 설명하는 대화 예시

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

7장. 치료 경로 지도

30초 요약: 자궁경부암 치료는 크게 세 갈래입니다. ① **수술 중심(초기)** · ② **항암방사선 + 근접치료(국소진행)** · ③ **전신치료 중심(원격전이)**. 경계에 있는 병기(IB3·IIA2)는 두 길이 모두 가능해 상의가 필요합니다.

경로	주로 해당	핵심 치료	기간 감각
① 수술	IA-IB2, IIA1 (일부 IB3·IIA2)	원추절제 / 자궁경부절제 / 자궁절제(A·B·C1형) + 림프절 평가	수술 + 회복 2~6주, 최종 병리 후 추가치료 결정
② 항암방 사선	IB3·IIA2(선택) , IIB-IVA	외부방사선 5~6주 + 주 1회 항암 → 근접치료, 전체 7~8주 내 완료	약 2개월 매일 통원
③ 전신치 료	IVB, 원격 재발	항암 + (조건에 따라) 면역치료 ± 혈관신생억제제, 국소치료 병행	수개월 단위, 반응 평가하며 조정

치료를 "겹치지 않게" 설계합니다. 수술 후 방사선까지 받게 되면 부작용이
늘 수 있습니다. 그래서 수술 전 영상에서 림프절 전이가 의심되거나 종양이
크면 처음부터 항암방사선을 선택하기도 합니다.

■ 완전판에서 이어집니다 — 병기별 시나리오 4가지(가상 사례)로 보는 치료
결정 과정

오늘 물어볼 질문

1. 제 병기에서 원하는 경로는 무엇이고, 다른 선택지는 무엇인가요?

2. 수술을 하면 수술 후 방사선이 추가될 가능성은 어느 정도인가요?
3. 결정까지 시간은 얼마나 있나요?

8장. 임신을 원한다면: 치료 전에 말하세요

30초 요약

- 아주 초기의 선별된 경우에는 **원추절제** 또는 **근치적 자궁경부절제**로 자궁을 보존할 수 있습니다.
- 방사선치료는 난소와 자궁에 영향을 줍니다. 가능성이 있다면 **치료 전에** 난자·배아 동결, 난소전위술을 상의합니다.
- 가임력 상담은 대개 **치료 일정 안에서 조율**할 수 있습니다. 걱정되면 "얼마까지 기다려도 안전한가요?"라고 직접 물어보세요.

병기별 가임력 보존 선택지 (조건을 모두 충족할 때, 담당 의료진 확인 필요)

병기	가임력 보존 방법
IA1	원추절제(LVSI가 있으면 림프절 평가 추가)
IA2	원추절제 + 골반 림프절 평가
IB1 저위험(LVSI 없음 등)	원추절제 + 골반 림프절 평가
IB1 그 외	근치적 자궁경부절제 + 림프절 평가
IB2	드물게 시행. 경험 많은 센터에서 신중히
IB3 이상	일반적으로 대상 아님

- 소세포 신경내분비암 등 일부 조직형은 가임력 보존 수술 대상이 아닙니다.
- 보존 수술 후 임신은 조산 위험이 있는 **고위험 임신**으로 관리합니다.

- **임신 중에 진단됐다면:** 조직검사는 임신 중에도 안전하게 할 수 있습니다. 병기와 임신 주수에 따라 바로 치료할지, 아기가 태어날 수 있는 시기까지 미룰지를 산과와 부인종양팀이 함께 정합니다.
- **난소전위술:** 방사선 범위 밖으로 난소를 옮겨 난소 기능을 지키는 수술로, 폐경 전·폐경상피암에서 주로 고려합니다. 자궁이 받는 방사선의 영향(임신 능력)까지 막지는 못합니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 가임력 보존 2주 결정 타임라인, 난자·배아 동결 실무, 자궁 보존 체크표

오늘 물어볼 질문

1. 제 병기와 조직형에서 자궁 보존이 안전하게 가능한가요?
2. 방사선 가능성이 있다면 난자·배아 동결이나 난소전위를 지금 상의해야 하나요?
3. 가임력 보존 준비로 치료를 얼마나 미뤄도 괜찮나요?

9장. 초기 자궁경부암 수술

30초 요약

- 수술 범위는 **원추절제 → 단순(A형) 자궁절제 → 근치(B·C1형) 자궁절제** 순으로 넓어집니다.
- 저위험 기준(LVSI 없음 등)을 충족하는 IA2·IB1은 **단순(A형) 자궁절제 + 림프절 평가**가 가능하다는 것이 최근 권고입니다.
- 그 밖의 IA2·IB1, IB2·IIA1은 **C1형 근치 자궁절제 + 림프절 평가**가 일반적입니다.

수술	무엇을 떼어내나	주로
원추절제(LEEP·냉원추절제)	자궁경부의 원뿔 모양 조직	진단, IA1, 가임력 보존

수술	무엇을 떼어내나	주로
근치적 자궁경부절제	자궁경부 + 질 상부 일부, 자궁· 난소는 남김	가임력 보존 IB1
A형(단순) 자궁절제	자궁(자궁경부 포함)만	IA1, 저위험 IA2·IB1
B형 근치 자궁절제	자궁 + 주변 지지조직 일부 + 질 상부 소량	선택된 경우
C1형 근치 자궁절제	자궁 + 지지조직 상당 부분 + 질 상부 1/4~1/3	IA2·IB1(저위험 외), IB2, IIA1, (IB3·IIA2 수술 시)

림프절 평가

- 골반 림프절 절제 또는 **감시림프절 생검**(암이 처음 퍼지는 림프절만 찾아 떼어냄)을 합니다. 필요하면 대동맥주위 림프절도 확인합니다.
- 림프절을 많이 떼면 다리 림프부종 위험이 생길 수 있습니다(PART 4).

수술 방법: 개복 vs 복강경·로봇

근치 자궁절제는 **개복 수술이 표준으로 권고**되며, 최소침습(복강경·로봇) 근치 자궁절제는 연구에서 재발 위험 증가가 보고되었습니다. 단순 자궁절제나 림프절 수술은 최소침습으로 하기도 합니다. 제안받은 수술 방법과 그 이유를 꼭 물어보세요. 근치 수술 뒤 배뇨·배변 장애를 줄이려고 **신경을 보존하는 근치 자궁절제**를 하는 병원도 있으니, 내게 해당되는지 물어볼 수 있습니다.

난소는 보존하나요?

폐경 전이라면 난소를 남길 수 있는지 상의합니다. 난소를 떼면 즉시 폐경 증상(수술적 폐경)이 생기고, 장기적으로 뼈·심혈관 건강에 영향을 줄 수 있습니다. 선암은 난소 전이 가능성 때문에 판단이 다를 수 있습니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 수술 전 준비물, 입원·회복 타임라인

퇴원 후 38°C 이상 발열, 상처 발적·고름, 소변을 전혀 못 봄, 한쪽 다리 부종은 바로 연락합니다.

수술 전 기록: 수술명 ___ · 수술 방법(개복/복강경/로봇) _ · 난소 보존 · 림프절 평가 방법 · 수술 후 방사선 가능성 ____

오늘 물어볼 질문

1. 제 경우 어떤 형태의 자궁절제(또는 보존 수술)를 권하시고, 그 이유는 무엇인가요?
2. 수술 방법(개복/최소침습)은 무엇이며, 재발 위험과 회복의 장단점은요?
3. 난소를 보존할 수 있나요?

10장. 수술 후 최종 병리와 추가치료

30초 요약

- **고위험 인자**(림프절 전이, 절제면 양성, 자궁주위조직 침범) 중 하나라도 있으면 **수술 후 항암방사선**(± 질 근접치료)을 권합니다.
 - **중간위험 인자**(큰 종양, 깊은 기질 침윤, LVSI)가 겹치면 **수술 후 방사선**(± 항암)을 고려합니다.
 - 위험 인자가 없으면 추적관찰로 넘어갑니다.
-
- 수술 전 예상 병기와 수술 후 병기가 다를 수 있습니다. 더 많은 조직 정보가 생긴 결과입니다.
 - 수술 후 요실금·방광 기능 저하, 림프부종, 질 건조는 치료할 수 있는 부작용입니다. 숨기지 말고 알려 주세요.
 - 난소를 보존했어도 방사선이 추가되면 난소 기능 보호를 다시 상의할 수 있습니다.

최종 병리 기록: 림프절 _/_ · 절제면 _ · **자궁주위조직** _ · 종양 크기 _ · **기질 침윤** _
· LVSI _____ → 추가치료 ☐없음 ☐방사선 ☐항암방사선

11장. 국소진행성: 항암방사선 + 근접치료

30초 요약

- IIB~IVA(그리고 선택된 IB3·IIA2)는 **외부방사선 + 동시 항암** → **근접치료**가 근치 치료의 핵심입니다.
- 외부방사선은 보통 **주 5회 × 5~6주**, 근접치료는 외부방사선 **마지막 주 또는 직후**에 시작합니다.
- **전체 치료를 7~8주 안에 마치는 것이 이상적입니다.** 임의로 쉬지 말고, 쉬어야 할 일이 생기면 치료팀과 먼저 상의하세요.

☞ **7~8주 원칙 상자** 1~5(6)주: 외부방사선 매일(평일) + 주 1회 항암 → 마지막 주 또는 직후: 근접치료 3~5회(약 2주) → **총 7~8주 내 완료** 근접치료 장비가 없는 병원이라면 **치료 시작 전에** 연계 병원과 근접치료 날짜를 확보하세요.

함께 쓰는 약

- **동시 항암:** 주로 **시스플라틴 주 1회**. 방사선 효과를 높이는 역할(방사선감작제)입니다. 신장 기능이 나쁘면 카보플라틴으로 바꿀 수 있습니다.
- 귀울림·청력 변화, 소변량 감소, 손발 저림은 다음 투약 전에 알려 주세요.
- **최근 선택지(모든 환자 대상 아님, 국내 허가·급여 확인 필요)**
- 병기에 따라 항암방사선에 **면역치료**(대표 예: 펌브롤리주맵)를 함께 쓰는 전략
- 항암방사선 전에 짧은 **유도항암**(카보플라틴 + 파클리탁셀)을 하는 전략
- 대동맥주위 림프절 전이가 있거나 의심되면 방사선 범위를 복부까지 넓힙니다.

치료 중 흔한 부작용

피로, 설사·복통, 빈뇨·배뇨통, 메스꺼움, 피부 자극, 혈구 감소. 대부분 치료 중 조절할 수 있습니다. **설사로 물을 유지하지 못하거나 38°C 이상 발열**이 있으면 바로 연락합니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 7~8주 주차별 치료 캘린더와 주차별 부작용·대처·보호자 동행일

치료 일정 기록: 외부방사선 시작일 __ · 동시항암 약/요일 _ · **근접치료 병원·횟수** · **목표 종료일** · **면역치료/유도항암 해당** ____

오늘 물어볼 질문

1. 근접치료는 언제, 어디서, 몇 회 하나요? 전체 종료 목표일은요?
2. 저는 면역치료 병용이나 유도항암 대상인가요?
3. 치료 중 어떤 증상이면 밤에도 연락해야 하나요?

12장. 근접치료 — 빼면 안 되는 이유와 하루 안내

30초 요약

- 근접치료는 방사선원을 자궁경부 종양 **바로 옆**에 두어, 주변 장기를 덜 다치게 하면서 종양에 높은 선량을 주는 치료입니다.
- 외부방사선만으로는 이 선량을 줄 수 없어 **다른 치료로 대체할 수 없습니다.**
- 통증과 불편은 **마취·진정과 진통제로 조절**합니다. 불편하면 말하면 조절할 수 있습니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 근접치료 당일 흐름, 준비물, 끝난 뒤 관리

오늘 물어볼 질문

1. 근접치료는 몇 회이고, 입원이 필요한가요?
2. 마취나 진정은 어떻게 하나요?
3. 질 확장기는 언제부터, 어떻게 쓰나요?

13장. 재발·전이로 진단받았다면: 바이오마커와 전신치료

30초 요약

- 원격전이(IVB)나 재발에서는 **바이오마커 검사**가 치료 선택의 출발점입니다. 특히 **PD-L1**(면역치료가 잘 들을지 보는 표지)이 1차 치료 선택에 중요합니다.
- 1차 치료는 **백금 항암 + 파클리탁셀**을 바탕으로, 조건에 따라 **면역치료**나 **혈관신생억제제(베바시주맵)**를 더합니다.
- 출혈·통증 같은 증상에는 방사선 등 국소치료를, 처음부터 **완화의료**를 함께 받을 수 있습니다.

바이오마커 검사(모든 재발·전이에서 권장)

검사	쉬운 뜻	왜 보나
PD-L1(CPS)	면역치료 반응 가능성 표지	1차 면역치료 병용 여부
HER2	특정 단백질 과발현	일부 표적치료·임상시험
MMR/MSI	DNA 오류 수선 기능	면역치료 대상 판단
TMB	종양 돌연변이 양	일부 면역치료 기준
RET 융합	드문 유전자 변화	표적치료 가능성
NTRK 융합	드문 유전자 변화(주로 자궁경부 육종)	표적치료 가능성

- 가능하면 조직으로 검사하고, 어렵다면 혈액으로 검사하기도 합니다. 진단 초기에 미리 검사하는 병원도, 재발 때 하는 병원도 있습니다.
- 바이오마커는 "많이 할수록 좋은 것"이 아닙니다. 치료 선택에 쓰일 검사를 시점에 맞게, 국내 허가·급여와 함께 확인합니다.

치료 단계 (범주, 국내 허가·급여 확인 필요)

1차 — PD-L1 양성: 백금 + 파클리탁셀 + 면역치료(대표 예: 펌브롤리주맵) ± 베바시주맵 ↳ 그 외: 백금 + 파클리탁셀 + 베바시주맵(± 다른 면역치료 조합)
 2차 — PD-L1 양성·MSI-H/dMMR·TMB-H: 면역치료 ↳ 그 외: 항체-약물접합체(ADC, 대표 예: 티소투맵 베도틴) 등

골반 안에만 재발했다면

- 이전에 방사선을 받지 않았고 절제가 가능하면 **수술 후 방사선 + 항암**을 고려합니다.
- 이미 방사선을 받았다면 위치에 따라 **골반 내장 적출술**(방광·직장 등을 함께 떼고 재건) 같은 큰 수술, 재방사선, 전신치료 등을 경험 많은 센터에서 상의합니다.

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

■ 완전판에서 이어집니다

- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 전이성 증상별 대처표

바이오마커 기록: PD-L1 CPS _ (**검사법** _) · HER2 _ · **MMR/MSI** _ · TMB _ · **RET/NTRK** _ · 이전 골반 방사선 ☐없음 ☐있음

오늘 물어볼 질문

1. 제 치료 목표는 무엇이고, 1차 치료로 무엇을 권하시나요?
2. 바이오마커 검사는 어떤 것을 했고, 결과는 무엇인가요?
3. 제가 참여할 수 있는 임상시험이 있나요?

14장. 신경내분비암(소세포암)이라면

30초 요약: 자궁경부 신경내분비암은 드물고 빨리 자랄 수 있어 **일반 자궁경부암과 다른 경로를** 따릅니다. 병리 재확인 and 경험 많은 센터의 다학제 진료, 임상시험 참여를 적극 고려합니다.

- 4cm 이하 초기: 근치 자궁절제 후 항암 또는 항암방사선, 또는 처음부터 항암방사선 + 근접치료.
- 4cm 초과·국소진행: 항암방사선 + 근접치료를 우선하며 이후 항암을 더할 수 있습니다.
- 재발·전이: 소세포폐암과 비슷한 항암(백금 + 에토포시드) 범주, 이후 면역치료 등.
- 가임력 보존 수술과 난소전위술은 일반적으로 권하지 않습니다.

 **완전판에서 이어집니다** — 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법

PART 3. 30일 실행 로드맵

■ **완전판에서 이어집니다** — 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

배뇨·장 기능 변화

30초 요약: 근치 수술 뒤에는 소변 감각이 일시적으로 둔해지고, 골반 방사선 중에는 설사·빈뇨가 흔합니다. 대부분 조절할 수 있습니다. **소변이 나오지 않거나, 심한 설사·출혈, 새 옆구리 통증**은 바로 연락합니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 배뇨·장 증상 자가관리법과 골반저 재활

증상 기록: 하루 소변 _회 · 야간뇨 _ · 설사 _회 · 출혈 ☐없음 ☐있음 · 통증 _/10

성 건강·폐경·림프부종

30초 요약: 질 건조·협착, 성교통, 조기폐경 증상, 다리 림프부종은 **참아야** 하는 부작용이 아니라 치료할 수 있는 문제입니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 질 확장기·보습제·폐경호르몬요법, 림프부종 자가관리, 골 건강

추적: 재발 확인 + 후유증 관리

30초 요약: 치료 후 추적은 **진찰(골반 진찰)과 증상 확인**이 중심이고, 영상은 병기·치료에 따라 정해진 시점이나 증상이 있을 때 합니다.

시기	진찰 간격(일반적 예시, 위험도에 따라 다름)
치료 후 1~2년	3~6개월마다

시기	진찰 간격(일반적 예시, 위험도에 따라 다름)
3~5년	6~12개월마다
5년 이후	1년마다(개인 위험도에 따라 조정)

국내 자료로는 근치 수술을 받은 초기 환자의 5~20%가 재발하며, 그중 절반은 1년 안, 대부분은 3년 안에 생깁니다. 재발해도 일찍 찾으면 완치를 기대할 수 있는 경우가 있어, 처음 2~3년의 추적 일정이 특히 중요합니다.

- IB3·2·3·4A기이거나 방사선(항암방사선)을 받았다면 치료 종료 **3~6개월 뒤 PET/CT** 등을 할 수 있습니다.
- 가임력 보존 수술 후에는 골반 MRI를 6개월 뒤, 이후 2~3년간 매년 하는 방식이 제시됩니다.
- 세포검사(Pap)는 새 전암병변을 찾는 데 도움이 되지만 재발 발견에는 한계가 있습니다.
- **다음 진료까지 기다리지 말고 알릴 증상:** 새 질 출혈·분비물, 혈뇨·혈변, 골반·허리·다리 통증, 다리·배 부종, 지속되는 기침·숨참, 식욕 저하·체중 감소.

나의 추적 계획: 다음 외래 _ · **영상** _ · 세포/HPV 검사 _ · **재발·림프부종** _ · 폐경·골 건강 _____

 **완전판에서 이어집니다** — 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____ 점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

■ 완전판에서 이어집니다

- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
3. **제도는 바뀝니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

 **완전판에서 이어집니다** — 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 3개만 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다.

- 1. 제 진단은 전암병변인가요, 침윤성 자궁경부암인가요?
- 2. 정확한 조직형과 FIGO 병기는 무엇인가요?
- 3. 골반 MRI·PET/CT나 림프절 평가가 더 필요한가요?
- 4. 제 경우 수술과 항암방사선 중 어느 경로가 적합한가요?
- 5. 수술한다면 수술 방법과 수술 후 추가치료 가능성은요?
- 6. 항암방사선이라면 근접치료는 언제, 어디서, 몇 회이고 전체 종료일은요?
- 7. 임신을 원한다면 자궁·가임력 보존이 가능한가요?
- 8. 재발·전이라면 PD-L1 등 바이오마커 검사가 필요한가요?
- 9. 치료 중 바로 연락해야 할 증상은 무엇인가요?
- 10. 치료 후 림프부종·성 건강·폐경·배뇨 문제는 어디서 관리하나요?

내 자궁경부암 한 장 요약

항목	내 기록
진단	전암 / 미세침윤 / 침윤성 암
조직형	편평상피 / 선암 / 선편평 / 신경내분비 / 기타 _____
FIGO 병기	Stage _____ (✔️ 확정 / ⌚ 대기)
종양 크기	_____ cm
림프절	골반 _ · 대동맥주위 _

항목	내 기록
LVSI / 절제면	LVSI _ · 절제면 _
주요 영상	MRI _ · PET/CT _
가임력 희망	없음 / 있음 / 상담 필요
첫 치료	수술(종류 _____) / 항암방사선 + 근접치료 / 전신치료 / 기타
바이오마커	PD-L1 CPS _ · MSI/MMR _ · 기타 _____
산정특례	☐ 신청 ☐ 등록 완료 (날짜 _____)

오늘 꼭 물을 3가지: ① 제 FIGO 병기와 림프절 상태는? ② 첫 치료는 수술인가요, 항암방사선인가요? ③ 가임력 보존이나 근접치료 준비를 지금 시작해야 하나요?

 완전판에서 이어집니다

- 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)
- 자궁경부암 용어사전
- 자궁경부암 자주 묻는 질문 12
- 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
- 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크 달력

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Cervical Cancer, Version 2.2026. NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 자궁경부암 정보(센터 페이지 최종수정 2024.08.28본 확인), 대한부인종양학회 자료,

국민건강보험공단 산정특례 안내

- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 실지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- 출처 : 보건복지부·국립암센터 국가암지식정보센터 — 사실 확인에 참고한 자료(센터 문장·그림은 실지 않음). 더 자세한 암 정보와 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899(평일 9~18시).
- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.
- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.
- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
- 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.

완전판에는 이런 내용이 더 있습니다

- 가상 병리보고서 한 줄씩 해설, 수술 후 최종 병리 항목 해설
- 영상 판독지 용어 풀이, 수술적 림프절 병기 설명
- 파트너·가족에게 HPV를 설명하는 대화 예시
- 병기별 시나리오 4가지(가상 사례)로 보는 치료 결정 과정
- 가임력 보존 2주 결정 타임라인, 난자·배아 동결 실무, 자궁 보존 체크표
- 수술 전 준비물, 입원·회복 타임라인

- 7~8주 주차별 치료 캘린더와 주차별 부작용·대처·보호자 동행일
- 근접치료 당일 흐름, 준비물, 끝난 뒤 관리
- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 전이성 증상별 대처표
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법
- 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)
- 배뇨·장 증상 자가관리법과 골반저 재활
- 질 확장기·보습제·폐경호르몬요법, 림프부종 자가관리, 골 건강
- 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)
- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것
- 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트
- 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)
- 자궁경부암 용어사전
- 자궁경부암 자주 묻는 질문 12
- 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
- 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크달력

ApuDa.app — 더 많은 암·질환 교육 콘텐츠와 업데이트 Instagram 구독자 무료 배포판 · 상업적 재배포 금지

ApuDa | 아프지만, 다행이다. · <https://apuda.app/>